

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

SPIN · SOCIAL PHOBIA INVENTORY

Inventario de Fobia Social de Connor y Davidson – Instrumento multidimensional autoinformado de cribado, severidad y respuesta terapéutica

1. Identificación General del Instrumento

Nombre oficial	Social Phobia Inventory (SPIN)
Nombre en español	Inventario de Fobia Social
Sigla oficial	SPIN
Autores originales	Kathryn M. Connor, Jonathan R. T. Davidson, L. E. Churchill, A. Sherwood, E. Foa et al. (2000)
Adaptación hispanohablante	Julio Bobes et al. (2004); Banco de Instrumentos Básicos / CIBERSAM
Año de publicación original	2000 (validación y baremos en español en 2004)
Constructo primario	Espectro sintomático del trastorno de ansiedad social: miedo cognitivo, evitación conductual y reactividad somática
Formato de administración	Autoinforme estructurado con escala Likert de 5 puntos (0 = Nada a 4 = Extremadamente)
Población diana	Población clínica y comunitaria adolescente y adulta (≥ 14 años)
Tiempo de aplicación	5 a 8 minutos (17 ítems referidos a la última semana)
Régimen de acceso	Uso clínico y de investigación abierto con fines académicos y asistenciales (Duke University / CIBERSAM)

2. Fundamentación Conceptual y Marco Clínico

El **Inventario de Fobia Social** (SPIN) fue diseñado por Kathryn M. Connor y Jonathan R. T. Davidson en el Medical Center de la Universidad de Duke para superar las limitaciones de instrumentos excesivamente largos (como el SPAI) o de escalas heteroadministradas que consumían un tiempo prohibitivo en la práctica ambulatoria ordinaria (como la LSAS). El objetivo fue crear un autoinforme breve, comprehensivo y de alta sensibilidad diagnóstica y psicométrica.

El marco conceptual del SPIN se apoya en el modelo tripartito de la ansiedad social propuesto por la Asociación Americana de Psiquiatría (DSM-IV y DSM-5), evaluando de manera simultánea e integrada las tres dimensiones cardinales de la fobia social: 1) **Miedo cognitivo-emocional** a la evaluación negativa, al escrutinio ajeno, a hacer el ridículo o a hablar con figuras de autoridad; 2) **Evitación conductual activa** de situaciones interpersonales, fiestas, hablar en público y eventos donde sea el centro de atención; y 3) **Síntomas neurovegetativos y somáticos**, prestando especial atención a las manifestaciones más angustiantes para los pacientes fóbicos sociales: rubor facial, sudoración profusa, temblores corporales y palpitaciones taquicárdicas. La versión española de Bobes et al. (2004) demostró una excelente capacidad de discriminación diagnóstica en centros de salud mental.

3. Dominios Evaluados y Composición de Ítems

Subescala / Dimensión	N.º Ítems	Rango	Contenido Clínico y Operacionalización
1. Miedo (Fear)	6 ítems	0 – 24	Temor a personas con autoridad, a hablar con desconocidos, a ser observado y a ser el centro de atención (ítems 1, 3, 5, 10, 14, 15).
2. Evitación (Avoidance)	7 ítems	0 – 28	Evitar hablar con personas, dar discursos, ir a fiestas, evitar hablar con extraños y evitar el escrutinio (ítems 4, 6, 8, 9, 11, 12, 16).
3. Malestar Fisiológico	4 ítems	0 – 16	Ruborizarse delante de la gente (ítem 2), sudar (ítem 7), palpitaciones cardíacas (ítem 13) y temblores musculares (ítem 17).
Puntuación Total SPIN	17 ítems	0 – 68	Suma directa de las 3 subescalas. Corte clínico estandarizado: ≥ 19 puntos.

4. Validez, Confiabilidad y Rendimiento Diagnóstico en España / LatAm

Propiedad Métrica	Coefficiente / Hallazgo	Contexto Empírico y Validación Hispana
Consistencia interna global	Alpha de Cronbach = 0.92 – 0.94	Sobresaliente consistencia interna en la validación española de Bobes et al. (2004).
Consistencia de subescalas	Alpha = 0.81 – 0.89	Miedo (0.89), Evitación (0.83) y Fisiología (0.81). Fiabilidad muy alta en los tres factores.
Fiabilidad test-retest	r = 0.85 – 0.89 (2 semanas)	Gran estabilidad temporal en pacientes antes de recibir tratamiento.
Sensibilidad diagnóstica	89.0% (punto de corte ≥ 19)	Excelente capacidad para identificar sujetos con Trastorno de Ansiedad Social.
Especificidad diagnóstica	90.0% (punto de corte ≥ 19)	Capacidad sobresaliente para discriminar fóbicos sociales de controles sanos y de otros trastornos de ansiedad.
Sensibilidad al cambio	Effect size d = 1.25	Capacidad altamente responsiva para capturar reducciones sintomáticas en ensayos clínicos con ISRS y TCC.

5. Reglas de Corrección y Cómputo de Puntuaciones

- **Escala Likert de 5 puntos referida a los últimos 7 días:**
 - 0 = Nada; 1 = Un poco; 2 = Moderadamente; 3 = Bastante; 4 = Extremadamente.
- **Cómputo de subescalas específicas:**
 - **Subescala Miedo:** Suma de los ítems 1, 3, 5, 10, 14 y 15 (rango 0 a 24).
 - **Subescala Evitación:** Suma de los ítems 4, 6, 8, 9, 11, 12 y 16 (rango 0 a 28).
 - **Subescala Síntomas Fisiológicos:** Suma de los ítems 2, 7, 13 y 17 (rango 0 a 16).
- **Puntuación Total SPIN:** Suma directa simple de los 17 ítems (rango global: 0 a 68 puntos).
- **Complejidad del protocolo:** No se admiten más de 2 ítems sin respuesta para considerar válida la prueba.

6. Baremos Normativos, Puntos de Corte y Estratificación Clínica

Puntuación Total	Estratificación Clínica	Significación Psicopatológica y Rendimiento Asistencial
0 – 18 puntos	Rango Normal / Subclínico	Ansiedad social normal o timidez adaptativa sin interferencia invalidante.
19 – 30 puntos	Fobia Social Leve	Punto de corte clínico formal (≥ 19). Fobia social identificada. Malestar interaccional claro. Sensibilidad y especificidad 90%.
31 – 40 puntos	Fobia Social Moderada	Ansiedad social generalizada con afectación manifiesta en vida social y laboral. Requiere abordaje formal.
41 – 50 puntos	Fobia Social Grave	Aislamiento interaccional severo, rubor/temblores invalidantes y evitación casi diaria.
51 – 68 puntos	Fobia Social Muy Grave / Crítica	Invalidez relacional total. Confinamiento en el hogar o incapacidad para trabajar ante público.

PUNTO DE CORTE DIAGNÓSTICO ESTÁNDAR (CONNOR ET AL., 2000; BOBES ET AL., 2004): Una puntuación ≥ 19 puntos optimiza simultáneamente la sensibilidad (89%) y la especificidad (90%) para el diagnóstico del Trastorno de Ansiedad Social; una reducción $\geq 50\%$ de la puntuación basal define la respuesta clínica terapéutica.

7. Algoritmo de Decisión Clínica e Intervención Asistencial

Paso 1: Cribado ágil en Atención Primaria o Salud Mental:

- Administrar el SPIN ante pacientes que consultan por temblor al firmar, rubor facial invalidante (**eritrofobia**), o bloqueo relacional.

Paso 2: Análisis del perfil somático vs. cognitivo:

- **Puntuación alta en Fisiología (ítems 2, 7, 13, 17 $\geq$ 10):** Fuerte componente neurovegetativo. Puede beneficiarse de betabloqueantes a demanda (Propranolol 10-40 mg) para situaciones específicas o ISRS para tratamiento de fondo.
- **Puntuación alta en Evitación ($\geq$ 16):** Requiere priorizar terapia de exposición graduada in vivo.

Paso 3: Estrategia de tratamiento según severidad total:

- **SPIN 19 – 30:** Terapia Cognitivo-Conductual (TCC) individual o grupal de 12 a 16 sesiones.
- **SPIN $\geq$ 31:** TCC estructurada combinada con ISRS (Sertralina 50-150 mg/día o Paroxetina 20-40 mg/día) o IRSN (Venlafaxina 75-150 mg/día).
- **Monitorización mensual:** Medir la curva de descenso del SPIN; mantener tratamiento de 6 a 12 meses tras la remisión ($<$ 19 puntos).

8. Caso Clínico Ilustrativo

Identificación: Mujer de 31 años, abogada junior, consulta por pavor paralizante a ruborizarse delante de los clientes y jueces, con episodios de sudoración profusa y temblores en las manos al sostener documentos.

Resultados en el SPIN:

- **Puntuación Total SPIN: 44 puntos / 68** (Fobia Social Grave).
- Subescala Miedo: 17 / 24 (temor a ser el centro de atención, miedo a personas con autoridad).
- Subescala Evitación: 15 / 28 (evita reuniones presenciales, delega intervenciones en compañeros).
- **Subescala Fisiológica: 12 / 16** (Ítem 2 = 4 rubor extremo; Ítem 7 = 3 sudoración; Ítem 13 = 2 palpitaciones; Ítem 17 = 3 temblores).

Tratamiento y Evolución Asistencial: El perfil del SPIN puso de manifiesto un cuadro grave de Fobia Social con severo componente fisiológico y eritrofobia. Se instauró tratamiento con Paroxetina 20 mg/día asociado a psicoterapia cognitivo-conductual basada en el protocolo de Clark y Wells (desactivación del foco interno de atención y experimentos de ruborización intencional). A los 4 meses, la puntuación total en el SPIN descendió a 16 puntos (remisión clínica completa), logrando asumir vistas judiciales sin interferencia emocional.

9. Alertas de Seguridad y Diagnóstico Diferencial

ALERTAS CLÍNICAS IMPORTANTES:

- **Eritrofobia y conductas de seguridad:** La vigilancia constante del rubor y el uso de maquillaje espeso o bufandas refuerza paradójicamente el bucle fóbico.
- **Comorbilidad depresiva:** Un SPIN $\geq$ 40 persistente suele acompañarse de episodios depresivos reactivos por aislamiento social.
- **Uso inadecuado de benzodiacepinas:** Alertar sobre el riesgo de dependencia a ansiolíticos consumidos como “muleta química” antes de cada interacción.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:

- **Agorafobia:** En la agorafobia el miedo es a no poder escapar o recibir ayuda en caso de crisis de pánico; en el SPIN el núcleo es el miedo al ridículo y al juicio ajeno.
- **Temblor esencial neurológico:** Descartar temblor familiar o idiopático orgánico antes de atribuir el temblor de manos únicamente a fobia social.
- **Trastorno Dismórfico Corporal:** El miedo surge del rechazo por un defecto físico percibido, no por la conducta de interacción social.

10. Referencias Bibliográficas Científicas

1. Connor, K. M., Davidson, J. R. T., Churchill, L. E., Sherwood, A., Foa, E., & Weisler, R. H. (2000). Psychometric properties of the Social Phobia Inventory (SPIN): New self-rating scale. *British Journal of Psychiatry*, 176(4), 379–386. <https://doi.org/10.1192/bjp.176.4.379>
2. Bobes García, J., G-Portilla, M. P., Bascarán, M. T., Sáiz, P. A., & Bousoño, M. (2004). **Banco de instrumentos básicos para la práctica de la psiquiatría clínica** (3.ª ed.). Ars Medica / Psiquiatría Editores.
3. Antony, M. M., Coons, M. J., McCabe, R. E., Ashbaugh, A., & Swinson, R. P. (2006). Psychometric properties of the Social Phobia Inventory: Further evaluation. *Behaviour Research and Therapy*, 44(8), 1177–1185. <https://doi.org/10.1016/j.brat.2005.08.013>
4. Radomsky, A. S., Ashbaugh, A. R., Saxena, P. R., Houle, G. M., Lavoie, S. L., O'Connor, K. P., ... & Dupuis, G. (2006). Psychometric properties of the French Social Phobia Inventory (SPIN). *Canadian Journal of Behavioural Science*, 38(4), 354–360.